HPTU — Nueva Sede

Validación de Demanda y Localización Estratégica

3.8 millones de registros · 15 fuentes oficiales · 6 preguntas respondidas

6 zonas evaluadas · 13 competidores analizados · Validación de demanda completa

Junta Directiva · 16 de marzo, 2026

básica

Agenda — 1 hora, 5 actos

8 min	**Acto 1** La Oportunidad — el hospital saturado, el mercado desatendido
10 min	**Acto 2** La Evidencia — brecha, tráfico, infraestructura, Oriente
15 min	**Acto 3** Validación de Demanda — 6 preguntas, 6 respuestas
12 min	**Acto 4** Análisis y Recomendación — MCDA, Access Point, financiero
10 min	**Acto 5** Decisión — POT, ruta, cronograma, preguntas
5 min	**Q&A** Preguntas abiertas

Plataforma interactiva: `https://hptu-localizacion.vercel.app`

Un hospital saturado, lejos de su mercado

El HPTU opera en **Robledo** con 540 camas hospitalarias:

- **174,543 predios** E5/E6 en **22 barrios** del corredor
- A **más de 20 minutos** del hospital
- Corredor Las Palmas: **0 camas** de alta complejidad
- **103,913 hab.** sin cobertura a 2037

El déficit es real

La OMS recomienda **3–5 camas** por cada 1,000 habitantes.

Municipio	Camas/1000
Medellín	1.0
Envigado	0.6
Itagüí	0.6
Sabaneta	0.5
OMS mínimo	**3.0**

Nos preguntamos

¿Dónde debe estar la nueva sede?

básica

La escala del análisis: datos, no opiniones

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Demanda	Flujos	Financiero	Recom.
✓	✓	En curso	Pendiente

Escala del análisis

Fuentes primarias	**15**
Registros procesados	**3.8M+**
Zonas evaluadas	**6**
Competidores perfilados	**13**
IPS georreferenciadas	**145**
Barrios analizados	**22**
Variables DENSURBAM	**59**
Periodo de datos	2017–2037

Modelo MCDA (score 0–100)

Cada zona se evalúa en 4 dimensiones:

$$\text{Score} = \underbrace{A \times 35\%}_{\text{Acc.}} + \underbrace{D \times 30\%}_{\text{Dem.}} + \underbrace{C \times 20\%}_{\text{Comp.}} + \underbrace{V \times 15\%}_{\text{Val.Inm.}}$$

Sensibilidad validada con **Monte Carlo** (3,000 iteraciones). Recomendación final pondera score + posición estratégica.

Fuentes: Catastro, REPS, MEData, DANE, POT, ProColombia, ANI, BDUA, Mapbox, Google Places.

El mercado: 174,543 predios E5/E6 en 22 barrios

Barrio	E5/E6	%	Avalúo
El Poblado core	**38,415**	**98**	$371M
Castropol	6,228	97	$327M
Los Balsos No. 1	4,019	95	$401M
San Lucas	3,671	93	$512M
Manila	2,144	96	$305M
Altos del Poblado	1,867	91	$245M
El Tesoro	1,856	89	$258M
+ 15 barrios más			
Total 22 barrios	**174,543**		

Fuente: Catastro Municipal Medellín (bp59-rj8r), 1,041,413 predios

Perfil del mercado

- **Prepagada**: SURA con **320,000 afiliados** en El Poblado
- **Colegios**: Colombo Británico, Montessori — 30 instit.
- **Clubes**: El Rodeo, Campestre Medellín
- **Corporativo**: Milla de Oro, Bancolombia (4,000 emp.)

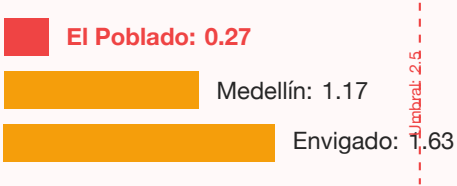
0 camas para este mercado

Ningún hospital en el corredor ofrece trasplantes, hematología ni oncología. HPTU sería el **único** de alta complejidad.

Corredor Las Palmas: **88–98%** E5/E6, avalúos **$245M–$512M COP**.

La brecha: un corredor sin hospital de alta complejidad

DENSURBAM confirma (Variable 49 — IRS Salud):



10 barrios del corredor tienen **0.0 m²** de oferta de salud.

IRS = Índice de Redistribución de Salud. El Poblado tiene **5 veces menos** infraestructura que el promedio de Medellín.

Fuente: DENSURBAM (URBAM-EAFIT/AMVA), 59 variables

Red hospitalaria actual:

Hospital	Camas	Dist.
HPTU Robledo	540	8.5 km
Cl. Medellín	184	3.2 km
HGM ESE	384	7+ km
Cl. del Prado	152	5+ km
Cl. CES	213	7.16 km
H. Uribe Ángel	120	Envigado
Total sistema	**1,593**	

En el corredor Las Palmas

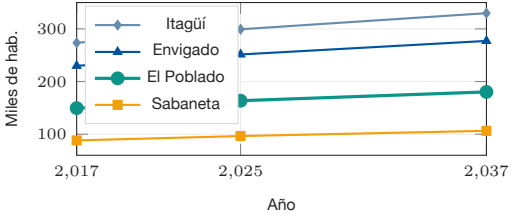
Cl. Rosario Tesoro	158 camas	sin trasplantes
Cl. Las Vegas	171 camas	sin oncología

0 camas de alta complejidad.

básica

Proyección 2037: crecimiento en dos frentes

Valle de Aburrá (DENSURBAM):



Valle de Aburrá: **+152K** personas a 2037. Fuente: DENSURBAM (DANE + AMVA).

Oriente Antioqueño (DANE + DNP):

Municipio	2018	2026	CAGR
Rionegro	116K	**138K**	**+2.0%**
La Ceja	59K	69K	+1.9%
Marinilla	55K	64K	+1.9%
El Carmen	54K	63K	+1.9%
Guarne	43K	49K	+1.7%
El Santuario	30K	35K	+2.0%
El Retiro	21K	24K	+1.7%
7 municipios	**378K**	**442K**	

La ecuación

Red de **1,593 camas** para 2.5M+ hab.
+ 152K Valle + crecimiento Oriente
+ 0 camas nuevas en el corredor

= Infraestructura requerida: **363,696 m²**

El Oriente crece al doble

Rionegro: **+2.0%** anual vs Medellín **+0.9%**.

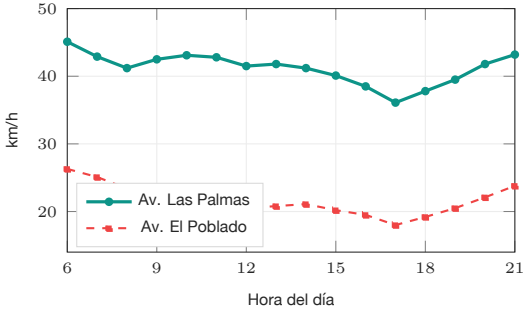
Proyección Rionegro 2030: **149K hab**.

Tasa migración neta: **5.2/100 hab/año** — el Oriente atrae población.

Fuente: DANE CNPV 2018 (evm3-92yw), DNP Proyecciones

El tráfico: Las Palmas fluye, El Poblado colapsa

Con **682,502 observaciones** de MEData (2017–2020):



Fuente: MEData Velocidad Tiempo Viaje GT (7t5n-3b3w)

A las **5:00 PM** (hora pico):

18.0 km/h
Av. El Poblado — congestión severa

40.9 km/h
Av. Las Palmas — **100% más rápido**

Desde 6 orígenes a Las Palmas Bajo:

Milla de Oro	**15.4 min**
El Poblado	**17.7 min**
Envigado	24.8 min
Laureles	32.3 min
Promedio	**26.6 min**

básica

Infraestructura vial: COP $1.96 billones en camino

Proyecto	Inversión	Status	Timeline	Impacto en Km 7
2da Etapa Túnel Oriente	$1.8 bill.	Construcción	H2 2027	**CRÍTICO**: doble calzada, Km 7 nodo de entrada
Intercambio Alto Palmas	$18,000M	Planeado	Q2 2026	DIRECTO: elimina congestión aguas arriba
Vía Aeropuerto-Belén	$120,000M	Planeado	Q2 2026	ALTO: circuito hospital-aeropuerto
Vía Llanogrande-Cañada	$120,000M	Planeado	2026+	ALTO: alimenta tráfico corredor túnel
Doble calzada Ceja-Rionegro	N/D	Construcción	Mar 2026	MEDIO: flujo intra-Oriente

Convergencia vial en Km 7

1. Túnel doble calzada (H2 2027) = **Rionegro a 25 min**
2. Intercambio Alto Palmas = **cero congestión**
3. Vía Aeropuerto = **circuito completo**

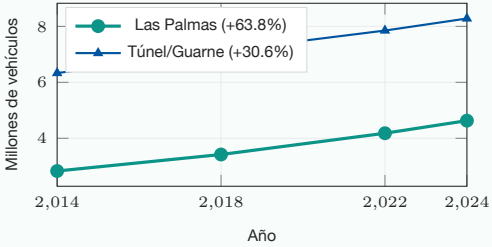
Km 7 queda en la **intersección de las 3 obras**.

Otros proyectos en evaluación

- Tren Medellín-Oriente: estudios ($3,421M)
- Tren Ligero Rionegro: **anulado** (fallo judicial)
- Vía Santa Elena: mejoramiento ($5,500M)

Fuente: ANI, INVIAS, Gobernación de Antioquia, Plan Maestro JMC 2055

El Oriente crece: la demanda viene hacia nosotros



Fuente: ANI peajes (8yi9-t44c), 2014–2024 exactos

Tráfico Las Palmas: de 2.8M a 4.6M veh/año. **+63.8% en 10 años.** La demanda de servicios de salud sigue al tráfico.

4 señales de crecimiento:

Indicador	Valor	Trend
Rionegro CAGR	**+2.0%**	↑
Tráfico Las Palmas	**+63.8%**	↑
Aeropuerto JMC	14.5M → 42.7M	↑
Migración Oriente	5.2/100 hab	↑
Prepagada Antioquia	+37% (2022-25)	↑
Turismo médico	+15% CAGR	↑
2da etapa Túnel	H2 2027	↑
PIB Oriente/Antioquia	10.4%	↑

La evidencia muestra

8 de 8 indicadores apuntan hacia arriba. No es una apuesta — es una tendencia consolidada.

Oriente Antioqueño: 728,000 habitantes, infraestructura crítica

Infraestructura de salud (11 municipios):

Municipio	Camas	/1000	Gap OMS
Rionegro	656	4.86	—
La Ceja	240	3.48	—
Guarne	184	3.73	—
El Carmen	37	**0.59**	+1.91
Marinilla	27	**0.42**	+2.08
El Retiro	26	**1.08**	+1.42
El Santuario	6	**0.17**	+2.33
Total Oriente	**1,199**		

Fuente: REPS capacidad instalada (b4dp-ximh), DANE est. 2026

3 datos críticos del Oriente

1. **55%** de las camas concentradas en Rionegro
2. **0 hospitales** nivel 3–4 en toda la región
3. **4 municipios** con menos de 1 cama/1000 hab

Solo **Cl. Somer** ofrece oncología (única UFCA) y radioterapia (único equipo) en todo el Oriente.

Mercado contributivo Oriente

Afiliados contributivos	**384,171**
Ratio C/S	**3.46×**
Rionegro % contributivo	**85%**
SURA dominancia	64–79% del mercado
Prepagada Antioquia	+37% (2022–2025)
Zona Franca	300+ empresas, 12K emp.

Fuente: BDUA marzo 2026 (ADRES)

Demanda capturable: 45,000 consultas/año desde el Oriente

Flujo de pacientes Oriente → Medellín:

Oriente: 728K hab
necesitan especialización

↓

~218K/año
requieren atención esp.

↓

~65K viajan a Medellín
30% de la demanda

↓

Access Point intercepta
45K consultas/año

Fuente: REPS, SISPRO 2023, modelo de demanda ambulatoria

Portafolio capturable:

Servicio	Vol./año	Revenue
Consulta especializada	18,000	$3,240M
Cirugía ambulatoria	6,500	$2,600M
Imágenes diagnósticas	9,000	$1,350M
Rehabilitación	7,000	$560M
Chequeo ejecutivo	4,500	$350M
TOTAL	**45,000**	**$8,100M**

Por qué Access Point intercepta

- **–17.8 min** vs HPTU a El Retiro y La Ceja
- Nodo de entrada del **Túnel** (H2 2027)
- **40–46%** de pacientes Rionegro son no residentes
- Zona Franca: 12K empleados sin chequeo ejecutivo

Oriente: 5 servicios críticos, 4 inexistentes

Servicio	Status Oriente	Nivel	Oportunidad HPTU
Cirugía Ambulat. Avanzada	Solo Campestre (recién)	**Crítico**	Hub quirúrgico especializado
Oncología Ambulatoria	Solo Somer (única UFCA)	**Crítico**	Quimioterapia, 2da opinión
Radioterapia	Solo Somer (único equipo)	**Crítico**	2do centro para la región
Imágenes Avanzadas	IMEDI + Somer (limitado)	Limitado	TAC, RMN, PET-CT
Rehabilitación Especial.	Básica únicamente	**Inexist.**	Neuro-rehab, cardíaca, deportiva
Chequeo Ejecutivo	Inexistente	**Inexist.**	Check-up Zona Franca + aerop.
Turismo Médico	0 infraestructura	**Inexist.**	0 JCI cerca de SKRG
Pediatría Subespec.	Solo en Medellín	**Inexist.**	Consulta ped. ambulatoria
Hemodiálisis	RCS Rionegro (41%)	Limitado	Expansión puntos diálisis

Monopolios en el Oriente

Somer tiene el **único equipo de radioterapia** y la **única UFCA** (oncología). Un solo proveedor para 728K habitantes. HPTU rompería ese monopolio con calidad JCI.

El Oriente necesita

3 servicios críticos + 4 inexistentes = oportunidad masiva para hub ambulatorio especializado que ningún competidor actual puede ofrecer con calidad HPTU.

Las 6 preguntas que la Junta necesita responder

Validación de demanda basada en evidencia

Q1: ¿Hay suficientes pacientes?

Brecha de oferta en el Oriente (7 municipios):

Municipio	Camas	Camas/1000	Gap OMS
Rionegro	656	4.86	–
La Ceja	240	3.48	–
Guarne	184	3.73	–
El Carmen	37	**0.59**	+1.91
Marinilla	27	**0.42**	+2.08
El Retiro	26	**1.08**	+1.42
El Santuario	6	**0.17**	+2.33

Fuente: REPS capacidad instalada (b4dp-ximh), DANE est. 2026

Los 3 datos que importan

1. Rionegro: **0 camas UCI** en 2023 (bajó de 0.14/1000)
2. Sobreocupación: **114%** en urgencias
3. **40–46%** de pacientes en Rionegro son **no residentes** (∼33,600/año)

Los pacientes **ya están viajando**. La pregunta no es si hay demanda — es quién la captura.

Respuesta

Sí. Sobran.

Q2: ¿Vendrán a Km 7?

Tiempos de viaje: **Km 7 vs HPTU** (hoy + post Túnel H2 2027):

Destino	Km 7	Post Túnel	HPTU	Ahorro
Aeropuerto	51’	**25’**	66’	**–41’**
Rionegro	59’	**25’**	57’	**–32’**
El Retiro	44’	**30’**	62’	**–32’**
La Ceja	66’	**40’**	84’	**–44’**
Guarne	56’	∼40’	40’	∼similar
Marinilla	68’	∼45’	59’	**–14’**

Hoy: Mapbox Matrix API. Post Túnel: estimación con doble calzada H2 2027 (Rionegro a 25 min desde Km 7).

Fuente: Mapbox Matrix API, ANI/INVIAS proyección Túnel 2da etapa

Post Túnel: Km 7 gana en todo

Con la doble calzada (H2 2027), Km 7 se convierte en el **nodo de entrada**:

- **Aeropuerto**: **25 min** (vs HPTU 66’)
- **Rionegro**: **25 min** (vs HPTU 57’)
- **El Retiro**: **30 min** (vs HPTU 62’)
- **La Ceja**: **40 min** (vs HPTU 84’)

Km 7 pasa de ganar en **3 de 7** destinos a ganar en **6 de 6**.

Respuesta

Sí. 6 de 6 post Túnel.

Q3: ¿Pueden pagar?

Afiliación EPS en el catchment (7 municipios, BDUA Mar 2026):

Municipio	Contrib.	Total	%C
Rionegro	169,749	199,690	**85%**
La Ceja	64,947	78,176	83%
Marinilla	47,398	67,067	71%
El Carmen	35,869	52,179	69%
Guarne	35,698	48,355	74%
El Retiro	15,530	19,268	**81%**
El Santuario	14,980	30,492	49%
TOTAL	**384,171**	**495,227**	**78%**

Fuente: BDUA marzo 2026 (ADRES)

3 indicadores clave

Ratio C/S	**3.46×**
Sura dominancia	**64–79%**
Total contributivo	**384,171**

El Oriente tiene un mercado **masivamente contributivo**. Sura es el contrato ancla obligatorio.

Contexto: Prepagada Antioquia creció **+37%** desde 2022. Revenue prepagada 2025: COP $7.2 billones.

Respuesta

Sí. Ratio 3.46×.

básica

Q4: ¿Crecerá la demanda?

8 indicadores de crecimiento — todos apuntan hacia arriba:

Indicador	Valor	Trend	Fuente	Año
Población Rionegro CAGR	+2.0%	↑	DANE CNPV 2018 + proy	2026
Tráfico Las Palmas 10yr	+63.8%	↑	ANI peajes (8yi9-t44c)	2024
Tráfico Túnel Oriente 10yr	+30.6%	↑	ANI peajes (8yi9-t44c)	2024
Pasajeros SKRG	14.5M → 42.7M	↑	Plan Maestro JMC 2055	2055
Prepagada Antioquia	+37% (2022-25)	↑	ADRES/Supersalud	2025
Turismo médico Antioquia	+15% CAGR	↑	ProColombia	2024
Tasa migración Oriente	5.2/100 hab/año	↑	DANE	2024
Doble calzada Túnel	H2 2027 apertura	↑	ANI/INVIAS	2027

Cada indicador por separado justifica atención. **Los 8 juntos** señalan una convergencia sin precedentes.

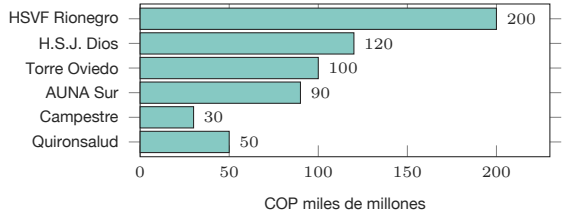
Respuesta

Sí. 8 de 8.

básica

Q5: ¿Otros ya validaron este mercado?

COP $590,000M invertidos por 6 instituciones:



Fuente: Prensa verificada, REPS, estados financieros

Señal del mercado

6 instituciones invirtiendo en el corredor:

- HSVF Rionegro: expansión a **500 camas**
- Torre Oviedo: **87 consultorios** (jun 2025)
- AUNA Sur: **168 camas** Envigado
- Campestre: **sede Rionegro** (mar 2026, 250 pac/día)

Ventana de oportunidad: **2026–2028**. Nicho ambulatorio premium será ocupado si HPTU no actúa.

Respuesta

Sí. COP $590,000M.

Paisaje competitivo: 13 instituciones perfiladas

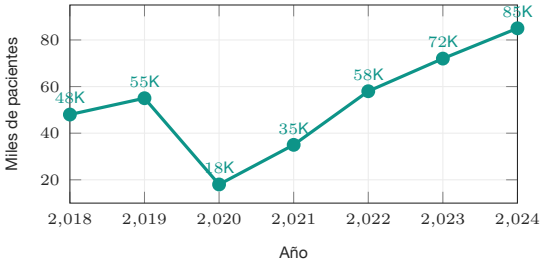
Institución	Camas	UCI	Ubicación	Complejidad	Movimiento reciente	Amenaza
HSVF Rionegro	152	—	Rionegro	alta	Exp. 500 camas, helipuerto	ALTA
Cl. Somer	200	19	Rionegro	alta	Trasplante cardíaco, oncol. ped.	ALTA
Cl. Rosario Tesoro	140	60	El Poblado	alta	Oncología integral	ALTA
Cl. del Campestre	—	—	Poblado + Rionegro	media-alta	Sede Rionegro mar 2026, 250 pac/día	ALTA
HSVF Medellín	525	208	Centro	alta	Exp. quemados	MEDIA
AUNA (Main + Sur)	492	—	Med + Envigado	alta	Sede Sur 168 camas	MEDIA
Quironsalud	812	—	Varios	alta	Adquis. COA + Clofan	MEDIA
Torre Oviedo	—	—	El Poblado	media-alta	87 consultorios, jun 2025	MEDIA
Proy. Alto Palmas	—	—	Las Palmas	media	En evaluación	MEDIA
IPS Universitaria	604	141	Varios	alta	N/D	BAJA
CardioVID	200	—	Medellín	alta	Planes exp.	BAJA
Cl. Vitha	201	36	Laureles	alta	Inaugurada 2024	BAJA
H. San Juan Dios	—	—	Rionegro	media	Torre $120,000M estudios	MEDIA

4 amenaza ALTA: todos en corredor sur-oriente.

Ninguno ofrece alta complejidad tipo HPTU.

Oportunidad: 10 categorías ambulatorias son **críticas o inexistentes** en el Oriente.

Q6: ¿Hay potencial de turismo de salud?



Fuente: ProColombia, DANE EVI, SISPRO

Top orígenes: EEUU (50.5%), Panamá (16.7%), Aruba (7.7%), Col. residentes exterior (4.0%)

3 KPIs del turismo médico:

85,000
pacientes/año (2024)

USD $235M
revenue anual

+11.9%
crecimiento YoY

Gasto promedio: **USD $2,764** por visita.

Estadía promedio: **14.2 noches**.

Ventaja JCI: HPTU es el único en Antioquia

Acreditación hospitalaria en Antioquia:

Hospital	Ciudad	Acred.	Rating	<30' SKRG
HPTU	Medellín	**JCI**	**4.4**	**No**
Cl. Somer	Rionegro	BPC	3.7	Sí
HSVF Rionegro	Rionegro	BPC	—	Sí
Cl. El Rosario	Medellín	BPC	3.3	No
Cl. Las Americas	Medellín	BPC	3.7	No
CardioVID	Medellín	BPC	—	No

JCI = Joint Commission International. Solo **6 JCI** en Colombia. HPTU es el **único en Antioquia**.

Fuente: REPS BPC, JCI Directory, Google Places

El dato clave

0 instituciones JCI a menos de 30 min del Aeropuerto SKRG.

HPTU campus: **57 min** al aeropuerto.
Access Point Km 7 (vía Túnel): **25 min**. Reducción: **–32 min**.

Captura potencial

Si Km 7 captura solo **5%** del turismo médico:

4,250 pac/año × USD $2,764
= **USD $11.7M adicionales/año**

Respuesta

Sí. USD $11.7M.

6 preguntas, 6 respuestas: todas Sí

Q1 ✓
¿Hay pacientes?
0 UCI, 114%
sobreocupación

Q2 ✓
¿Vendrán a Km 7?
–17.8 min
al sur del Oriente

Q3 ✓
¿Pueden pagar?
384K contrib.
ratio C/S 3.46

Q4 ✓
¿Crecerá la demanda?
8 de 8 ↑
indicadores up

Q5 ✓
¿Otros validaron?
$590,000M
6 instituciones

Q6 ✓
¿Turismo de salud?
USD $11.7M
captura 5%

La demanda está **validada por 6 dimensiones independientes**. El riesgo no es invertir — es **no actuar**.

Brechas ambulatorias en el Oriente: 10 servicios críticos

Servicio	Status Oriente	Nivel	Oportunidad HPTU
Cirugía Ambulat. Avanzada	Solo Campestre (recién)	**Crítico**	Hub quirúrgico: ortopedia, urología, ORL
Oncología Ambulatoria	Solo Somer (única UFCA)	**Crítico**	Quimioterapia, segunda opinión
Radioterapia	Solo Somer (único equipo)	**Crítico**	Segundo centro de radioterapia
Imágenes Avanzadas	IMEDI + Somer (limitado)	Limitado	TAC, RMN, PET-CT
Rehabilitación Especial.	Básica únicamente	**Inexist.**	Neuro-rehab, cardíaca, deportiva
Chequeo Ejecutivo	Inexistente	**Inexist.**	Check-up para ZF + aeropuerto
Turismo Médico	0 infraestructura	**Inexist.**	23,323 pac/año, 0 cerca SKRG
Pediatría Subespec.	En Medellín	**Inexist.**	Consulta pediátrica ambulatoria
Hemodiálisis	RCS Rionegro (41%)	Limitado	Expansión puntos de diálisis
Cardiología Interv.	Solo Somer Incare	Limitado	2do centro cardiovascular

3 críticos + 4 inexistentes = oportunidad masiva para hub ambulatorio especializado.

MCDA: 6 zonas evaluadas — el ranking

Modelo MCDA: Accesibilidad (35%) + Demanda (30%) + Competencia (20%) + Valor Inmobiliario (15%)

Zona candidata	Acc.	Dem.	Comp.	Valor	SCORE	min a HPTU
Las Palmas Bajo	**92**	**93**	**78**	**80**	**88**	23.8
Access Point Km 7	85	91	65	75	**81**	18.5
Las Palmas Medio	72	84	82	70	77	31.8
Envigado–Zúñiga	75	80	62	74	74	22.4
N. Poblado–Itagüí	82	68	52	58	67	19.0
Las Palmas Alto	42	52	90	62	**58**	57.1

#1 LP Bajo (88)

Score más alto en MCDA. POT 9/9.

#2 Access Point (81)

Recomendado: demanda dual Poblado + 460K Oriente + aeropuerto.

#6 LP Alto (58)

Descartado: 57 min a HPTU, suelo rural. Inviable.

Access Point Km 7: nuestra recomendación estratégica

Score MCDA	**81/100** (#2 — decisión estratégica #1)
Ubicación	Km 7 Vía Las Palmas, Retorno 5
Infraestructura	4 torres, 10 pisos, 1,085 parq.
A HPTU actual	18.5 min
A Aeropuerto	**25 min** (vía Túnel H2 2027)
A Rionegro	**25 min** (post doble calzada)
Pico y placa	**Sin restricción**

Catchment dual:

El Poblado
135K hab
E5/E6, 15 min

Oriente
460K hab
vía Túnel, 25 min

= 595K catchment total

Nodo estratégico del Túnel:

Medellín Centro
20 min

↓

ACCESS POINT
NODO Km 7

↓

Portal Túnel
15 min

↓

Rionegro / JMC
25 min post Túnel

Por qué es la recomendación

Único punto que conecta **dos mercados** simultáneamente: El Poblado (135K, E5/E6) y todo el Oriente (460K, 384K contributivos). Post Túnel, **ningún destino queda a más de 40 min**.

Score #2, decisión #1: ¿por qué Access Point?

Dimensión	Peso	LP Bajo	AP Km 7	Δ
Accesibilidad	35%	92	85	+7
Demanda	30%	93	91	+2
Competencia	20%	78	65	+13
Valor Inmob.	15%	80	75	+5
TOTAL		**88**	**81**	+7

Diferencia: **competencia** (40+ IPS en 5 km de AP).

Pero **ninguna** ofrece trasplantes, hematología ni JCI.

6 razones estratégicas

1. **595K** catchment dual (Poblado + Oriente)
2. **25 min** al aeropuerto (vía Túnel) — JCI
3. **45K consultas/año** capturable del Oriente
4. **Infraestructura lista**: 4 torres, 1,085 parq.
5. **Nodo Túnel**: Rionegro a 25 min (H2 2027)
6. **Oriente +2%** anual vs Medellín +0.9%

Lo que el MCDA no captura

El modelo evalúa **hoy**. No pondera la transformación que viene: Túnel doble calzada, Oriente creciendo al doble, aeropuerto triplicando.

Nuestra recomendación

El MCDA sitúa a LP Bajo como #1 en condiciones actuales. Pero la inversión mira a **10–15 años**. Los fundamentales del Oriente — 728K hab., +2% CAGR, 384K contributivos, aeropuerto triplicando, Túnel doble calzada — hacen de Access Point la **posición estratégica superior**. **Recomendamos Access Point Km 7.**

Isocronas de accesibilidad: ¿quién llega en cuánto tiempo?

Desde Access Point Km 7 (Mapbox Isochrone):

Isocrona	Cobertura
15 min	El Poblado sur, El Tesoro, San Lucas, Altos del Poblado
20 min	Milla de Oro, Envigado norte, Club El Rodeo
30 min	Todo El Poblado, Envigado, Laureles, acceso Túnel Oriente
45 min	El Retiro, Guarne, acceso aeropuerto
60 min	Rionegro, La Ceja, Marinilla, aeropuerto SKRG

135K habitantes en 15 min + **460K Oriente** en 45–60 min.

Post Túnel doble calzada (H2 2027):

Destino	Km 7	Post Túnel	HPTU	Δ
Aeropuerto	51’	**25’**	66’	**–41’**
Rionegro	59’	**25’**	57’	**–32’**
El Retiro	44’	**30’**	62’	**–32’**
El Poblado	10’	10’	24’	–14’
La Ceja	66’	**40’**	84’	**–44’**

Post Túnel, Km 7 gana en **todos los destinos** — incluyendo Rionegro donde hoy empata con HPTU.

Convergencia de evidencia: 5 pilares

SATURACIÓN	BRECHA	DEMANDA	VALIDACIÓN	TURISMO
540	**0**	**384K**	**590K**	**85K**
Camas HPTU	Camas alta complej.	Afiliados contrib.	MM COP invertidos	Turistas médicos
saturado	corredor	Oriente	6 instit.	+11.9% YoY

Cada pilar por separado justifica la exploración. **Los 5 juntos** constituyen el caso más sólido para expansión estratégica del HPTU.

No encontramos un solo indicador que contradiga la tesis. **La evidencia es unánime.**

Recomendación: Access Point Km 7 — Posición estratégica

Ubicación: Km 7 Vía Las Palmas, Retorno 5

Acierto Inmobiliario — nodo de entrada al Túnel

81/100 MCDA
#2 — decisión estratégica #1

595K catchment
Poblado + Oriente

25' al aeropuerto
vía Túnel doble calzada

45K consultas/año
demanda capturable Oriente

Parámetro	Valor
Infraestructura	4 torres, 10 pisos
Parqueaderos	**1,085**
A HPTU actual	18.5 min
A Aeropuerto (vía Túnel)	**25 min**
Catchment dual	**135K + 460K = 595K**
Pico y placa	Sin restricción
Post Túnel: Rionegro	**25 min**

¿Por qué AP sobre LP Bajo?

LP Bajo tiene score 88 (#1 en MCDA). Pero la inversión mira a **10–15 años**. Los fundamentales del Oriente — **728K hab**, crecimiento +2% anual, **384K contributivos**, aeropuerto triplicando, Túnel doble calzada — hacen de AP la **posición de mayor valor prospectivo**.

Modelo financiero: factibilidad por zona

Zona	Camas	Inv.	Payb.	VPN
LP Bajo	**250**	**$90MM**	**11.3y**	**+$4.8**
LP Medio	300	$108MM	9.4y	+$15.3
Envigado	220	$82MM	11.3y	+$4.0
N. Poblado	260	$98MM	9.6y	+$14.7
LP Alto	150	$55MM	**22.9y**	**–$31**

Miles de MM COP. WACC 12%, ramp-up 60%/80%/100%.

Parámetros base

Construcción/m²	$4.0M (Scielo/U. Militar)
Dotación	25% (DNP)
Ocupación	80% (estándar)
Ingreso/cama/año	$1,600M (HUSI) ▼
EBITDA	8% ▼
WACC	12% ▼

Sensibilidad

Si ingreso/cama = $2,000M (privado premium):

VPN LP Bajo: **+$4.8MM → +$25MM**

Este es el parámetro **más sensible** del modelo.

Viabilidad POT: 22 barrios, Altos del Poblado líder

Barrio	Score	CL_D	Pisos	Suelo (m²)
Altos del Poblado	**9/9**	2.38	11.7	68,020
El Tesoro	9/9	2.52	7.2	119,482
Castropol	8/9	1.89	7.1	65,591
Los Balsos No. 1	8/9	2.15	11.5	97,440
Los Balsos No. 2	6/9		16.7	132,161
Las Lomas No. 1	5/9		15.4	30,281
Las Lomas No. 2	5/9		20.0	—
+ 15 barrios más	1–7			

Fuente: POT Batería Indicadores (3ciz-tpgr), Acuerdo 48 de 2014

CL_D = Carga Localizada Dotacional. Valores >2.0 = aptos para uso dotacional de salud.

Altos del Poblado: máxima viabilidad

- CL_D = **2.38**
- ICS = 57.4 (capacidad de soporte)
- ICF = 2.78 (flujos favorable)
- Suelo: **68,020 m²**
- Altura: 11.7 pisos (250 camas)

Viabilidad por categoría

●	ALTA (8–9)	4 barrios
●	MEDIA-ALTA (6–7)	6 barrios
●	MEDIA (4–5)	7 barrios
●	BAJA (1–3)	5 barrios

▼ Pendiente: fichas normativas **por polígono** (DAP Medellín).

Lo que falta: 8 parámetros por validar

Parámetro	Prior.	Valor actual	Fuente de validación
Precio suelo/m² por zona	ALTA	$0.5–2.5M/m²	Lonja de Propiedad Raíz
Ingreso/cama/año	ALTA	$1,600M COP	Pablo Tobón, Las Américas
Margen EBITDA operativo	ALTA	8%	Supersalud (EE.FF.)
Fichas normativas POT	ALTA	Estimadas	DAP Medellín / GeoMedellín
Lotes disponibles	ALTA	8–15K m²	Inmobiliarias corredor
WACC del proyecto	MEDIA	12%	Banca de inversión
Costos diseño + licencias	MEDIA	18 meses est.	Arquitectura hospitalaria
IO/IC específico por lote	MEDIA	Estimados	Fichas normativas POT

Sensibilidad

Escenario	Ingreso/cama	VPN LP Bajo
Conservador (HUSI)	$1,600M	+$4.8MM
Privado premium	$2,000M	**+$25MM**
Privado alto	$2,200M	+$38MM

Riesgos identificados

1. Demoras en licenciamiento POT
2. Volatilidad costos de construcción
3. Cartera EPS (∼$14B COP sector)
4. Nuevos competidores en el corredor
5. Cambios regulatorios

Ruta a la decisión: Fases 3 y 4

Fase 3 — Profundización (en curso)

1. **Validar modelo financiero**
   Lonja, Supersalud, benchmark hospitales privados
2. **Due diligence POT**
   Fichas normativas específicas por polígono
3. **Identificar lotes**
   Búsqueda activa con inmobiliarias
4. **Competencia detallada**
   Servicios, tarifas por zona
5. **Análisis de sensibilidad**
   Escenarios sobre parámetros críticos

Fase 4 — Recomendación Final

1. Informe ejecutivo final
2. Shortlist de 2–3 lotes
3. Análisis de escenarios para decisión

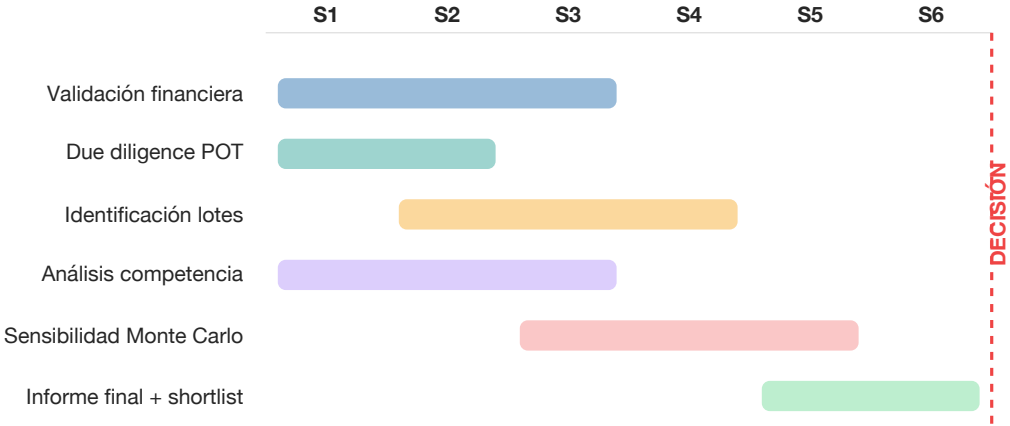
Entregables actuales

1. **Plataforma web** interactiva
   hptu-localizacion.vercel.app
2. **Dashboard de demanda** (6 preguntas)
3. **Base georreferenciada** (15 GeoJSON)
4. **Dashboard MCDA** (6 zonas)
5. **Modelo financiero** preliminar
6. **Perfiles de 13 competidores**
7. **Análisis turismo de salud**

Referencia

San Vicente Rionegro validó la expansión estratégica. Las Palmas Bajo sigue esa lógica: acercar alta complejidad al mercado E5/E6.

Cronograma propuesto: 6 semanas a la decisión



Semana 6: Presentación final a Junta Directiva con shortlist de lotes y recomendación definitiva

Síntesis ejecutiva

PROBLEMA	BRECHA	MERCADO	ANÁLISIS	FINANCIERO
540	**0**	**174K**	**AP**	**+4.8**
Camas HPTU	Camas alta complejidad	Predios E5/E6	Access Point Km 7	VPN 10y miles MM COP
saturado	corredor	mercado	recomendado	Payback 11.3y

Lo que los datos dicen

1. Sistema **saturado**, crecerá +152K personas
2. Corredor: **0 camas** de alta complejidad
3. **6 de 6 preguntas** respondidas con “Sí”
4. **Access Point Km 7**: posición estratégica para Oriente
5. VPN positivo en **4 de 5 zonas**

La decisión pendiente

Para pasar de recomendación a **decisión de inversión**:

1. Validar 5 supuestos financieros
2. Confirmar fichas normativas POT
3. Identificar 2–3 lotes concretos
4. Análisis de sensibilidad

6 semanas a la decisión final.

¿Preguntas?

HPTU — Nueva Sede

Validación de Demanda y Localización Estratégica

Plataforma interactiva:

`https://hptu-localizacion.vercel.app`

15 fuentes oficiales · 3.8M+ registros · 6 preguntas respondidas

6 zonas evaluadas · 13 competidores · Modelo financiero preliminar

básica

Todo es datos. Nada es opinión.